

32 - Les Hypnotiques - Pr. BENALI

(0:05 - 0:56)

Chers étudiants, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette dernière séance et qui intéressera deux cours qui sont, à mon sens, très intéressants et très importants, à savoir les hypnotiques et puis les neuroleptiques et les antipsychotiques. Un certain nombre de points et d'objectifs pédagogiques ont été fixés pour le premier cours qui s'intitule les hypnotiques et il va falloir, après cette séance, définir un hypnotique, connaître le mécanisme d'action et la classification des hypnotiques, cerner leurs indications, leurs contre-indications ainsi que les effets secondaires et surtout maîtriser leur modalité de prescription.

(0:59 - 2:29)

Il me semble que pour ce cours, les hypnotiques, il faut prêter attention à votre rôle de médecin de famille, à votre rôle de médecin généraliste, c'est que vous serez amené à les prescrire régulièrement. C'est le cas de tous les omnipraticiens pratiquement du Maroc et nous constatons, nous les psychiatres, qu'il y a quand même une prescription assez importante, assez parfois maladroite de ces molécules avec tout le corollaire que nous allons discuter durant cette séance. C'est pour cela que j'ai opté pour pratiquement le même plan que les cours précédents, à savoir une définition et dire quels sont les enjeux de cette question, parler des mécanismes d'action des hypnotiques qui montrent comment ces molécules agissent, notamment par rapport aux troubles du sommeil, les classer pour mieux choisir parmi les différentes catégories celui qui est le plus adapté par rapport à votre patient et maîtriser toute la partie sur les indications, les contre-indications ainsi que les effets secondaires et savoir prescrire, choisir et surveiller un patient sous hypnotique avant de conclure.

(2:32 - 3:28)

Un médicament hypnotique est un médicament qui est capable d'induire et de maintenir le sommeil avec pour corollaire une action dépressive sur le système nerveux central et respiratoire. Donc c'est d'abord l'induction du sommeil mais aussi le maintenir dans le temps afin que la personne, afin que le patient puisse améliorer à la fois la quantité d'heures passées au lit mais aussi la qualité du sommeil, on le verra plus tard. L'efficacité des molécules hypnotiques dépend de la diminution de la période de latence du sommeil ainsi que la réduction des réveils nocturnes et que le temps total du sommeil sera amélioré avec une évaluation subjective de la qualité du sommeil.

(3:31 - 4:14)

Cette question est très importante, pourquoi? Parce que l'insomnie est une plainte subjective fréquente, c'est un motif de consultation très très fréquent en médecine générale. Le deuxième point c'est que pour la soigner il y a deux approches à la fois non pharmacologiques et une qui

est pharmacologique et que le choix de cette stratégie dépend bien évidemment des caractéristiques du patient et comment se présente son insomnie. C'est ainsi que l'un des enjeux majeurs de cette question est d'optimiser le bon usage des hypnotiques.

(4:16 - 5:27)

Et pour cette raison dans le deuxième paragraphe on s'intéressera aux mécanismes d'action des hypnotiques qui ont d'abord une action inhibitrice sur le système nerveux central ce qui explique leur effet sédatif. Donc il y a une inhibition des systèmes monoaminergiques que ce soit la noradrénaline, la sérotonine ou la dopamine et selon la dose il y a un effet sédatif et un sommeil narcotique à des doses très importantes, on peut même assister à un coma. Cette inhibition qui va toucher les trois catégories des monoamines vont induire chez le patient le sommeil et provoquer bien évidemment un effet hypnotique qui malheureusement risque avec le temps de créer chez le patient un effet de tolérance et que le patient va chercher à augmenter les doses pour chercher, pour arriver à des effets identiques antérieurs.

(5:28 - 6:08)

C'est ainsi qu'un syndrome de sevrage ou d'un syndrome de dépendance s'installe chez notre patient. Le deuxième point qui me semble intéressant c'est que le mécanisme d'action va intéresser ce qu'on appelle les benzodiazépines apparentées qui agissent au niveau des récepteurs GABA et au niveau des récepteurs histaminiques. Au niveau des récepteurs du système GABA il y a une modification des paramètres du sommeil qui touche le délai d'endormissement et la durée des stades que vous avez déjà étudié notamment en neurologie.

(6:09 - 6:37)

Il y a ce qu'on appelle une augmentation du stade 2 et une réduction du stade 4 qui est le sommeil long, profond et le sommeil paradoxal. Avec ces molécules benzodiazépines apparentées il y a ce qu'on appelle un échappement thérapeutique. Ça veut dire quoi ? Au bout de 2 à 4 semaines le traitement n'aura pas le même effet qu'en début du traitement.

(6:37 - 7:10)

Au bout d'un mois, le patient aura limite un échappement thérapeutique, une sorte de résistance, de tolérance par rapport au traitement. Le troisième point étant une autre catégorie des hypnotiques qui est les agonistes des récepteurs de la mélatonine. Elle exercerait son action sur le sommeil par fixation sur les récepteurs de la mélatonine qui sont présents au niveau des noyaux suprachiasmatiques.

(7:11 - 7:38)

Ces récepteurs sont appliqués dans l'induction du sommeil et la modulation des rythmes

circadiens. Les hypnotiques, qu'on appelle aussi des somnifères ont une biodisponibilité qui est très bonne. Elle se fait par voie orale et on assiste à une bonne distribution parce que ce sont des molécules qui sont très lipophiles.

(7:39 - 8:29)

Leur demi-vie plasmatique est variable mais il faut savoir aussi que certaines molécules benzodiazépines donnent naissance à des métabolites actifs ou inactifs qui ont une distribution et une biodisponibilité tout à fait différente de la molécule mère. Quant aux propriétés pharmacodynamiques la vitesse d'élimination est variable. On peut avoir une vitesse d'élimination très courte comme c'est le cas du zolpidène ou très longue comme le chlorazépate qui est un anxiolytique.

(8:33 - 9:11)

Que dire des mécanismes d'action des hypnotiques en résumé ? Ce qu'il faut retenir c'est que les hypnotiques inhibent les systèmes monoaminergiques au niveau central. Ces deux systèmes sont essentiellement le système GABA et l'histamine ce qui explique leur effet sédatif l'induction du sommeil et la modification des stages. Un des effets secondaires le plus majeur étant l'échappement thérapeutique.

(9:17 - 26:26)

Au niveau du chapitre sur les mécanismes d'action vous avez constaté qu'on avait déjà évoqué les différentes catégories que je vais reprendre ici en quatre sous-groupes à savoir les benzodiazépines et les principes actifs apparentés les hypnotiques anti-histaminiques de première génération les agonistes des récepteurs de la mélatonine et d'autres molécules qui sont utilisées à viser hypnotiques Pour le chapitre 3 qui s'intéresse aux classifications des hypnotiques nous commencerons par la première catégorie qui est représentée par les benzodiazépines et les principes actifs apparentés Les benzodiazépines ont une forte affinité pour le récepteur GABA et pour les principes actifs apparentés il y a deux grandes classes qui sont connues et largement utilisées au Maroc qui sont les cyclopyrillone, le zopiclone et les imidazoperidine qui sont commercialisés sous le nom de stinox c'est le zolpidem ces deux dernières catégories, ou plutôt les trois réduisent le délai d'endormissement diminuent le nombre des événements nocturnes et on assiste à une augmentation de la durée totale du sommeil Pour le zopiclone et le zolpidem leur action sur l'architecture du sommeil est plus discrète que celle des benzodiazépines nous assistons ainsi à une augmentation du stade 2 sans modification des stades 3 et 4 du sommeil lent et on n'a pas de modification du sommeil paradoxal Pour les médicaments hypnotiques anti-histaminiques de première génération ils ont une forte affinité pour le récepteur H1 nous citons l'alimémazine, le Terralen l'hydroxyzine, qui est un anti-histaminique, la Tarax et la prometazine, le Phenergan nous assistons avec ce médicament à une réduction du délai d'endormissement à une diminution du nombre des éveils et une augmentation de la durée totale du sommeil Ce sont

des molécules lipophiles qui ont un volume de distribution élevé Quant à la nouvelle classe qui est représentée par les agonistes des récepteurs de la mélatonine elle entraînerait une diminution du délai d'endormissement un allongement du temps total du sommeil sans modification majeure de l'architecture du sommeil La quatrième catégorie, ce sont d'autres molécules qui sont utilisées à visée hypnotique et je citerai à titre d'exemple un neuroleptique sédatif qui s'appelle le Levomepromazine, le Nozinan l'antidépresseur Amitriptyline, l'Aroxyl et je dirais que ces deux molécules existent au Maroc sous forme de solutions buvables, sous forme de gouttes ce qui facilite largement leurs prescriptions notamment en termes d'augmentation de posologie et de dégression des médicaments et il y a d'autres médecins qui peuvent utiliser la phytothérapie pour induire 100 données de médicaments hypnotiques de sommeil chez leurs patients et retrouver une qualité de vie meilleure Les médicaments hypnotiques sont indiqués principalement dans les insomnies et comme vous le savez parfaitement bien l'insomnie peut être de courte durée c'est-à-dire transitoire et à court terme et parfois on a des insomnies chroniques donc la première indication étant l'insomnie à court terme c'est-à-dire qui est transitoire et elle dépend bien évidemment des caractéristiques du patient et surtout des caractéristiques de la plainte ce qui va vous amener plus tard en tant que médecin d'opter par l'approche éducative avant d'entamer ou avant de prescrire un hypnotique savoir si cette insomnie est liée à une pathologie organique est liée à la prise d'autres médicaments ou est en rapport avec une pathologie psychiatrique L'insomnie à court terme est généralement très fréquente elle semble être liée à la dimension du stress réactionnelle à des événements de vie comme le deuil, etc. Alors que pour l'insomnie chronique le traitement de premier choix étant la thérapie cognitivo-comportementale qui est marquée ici par les initiales TCC et on ne donnera des hypnotiques que si échec de ces TCC et il faut traiter au maximum durant 4 semaines par les benzodiazépines Les contre-indications des hypnotiques ont été résumées dans ce tableau à titre pédagogique et pour vous faciliter la tâche pour mieux les retenir Il faut savoir que l'insuffisance respiratoire sévère le syndrome d'apnée du sommeil la myasthémie sévère ou une hypersensibilité étant des contre-indications aux benzodiazépines et aux composés apparentés Tout ce qui est anti-histaminique est lié notamment au risque que le patient développerait un glaucome à une rétention urine C'est ainsi que la contre-indication principale ou les contre-indications principales étant le risque de glaucome par fermeture de longue risque de rétention urinaire ou lié à des troubles urethroprostatiques une hypersensibilité et bien évidemment pour l'hydroxyzinatarax toute pathologie susceptible d'entraîner un allongement de l'espace cuté Pour la mélatonine, il n'y a qu'une seule contre-indication qui est l'hypersensibilité à l'un des composants Les effets indésirables des hypnotiques sont elles aussi représentés dans pratiquement le même tableau sur le plan architectural et je citerai les plus importantes à savoir les troubles neuropsychiques On peut avoir une somnolence, une amnésie antérograde avec une diminution des capacités motrices une insomnie rebond et surtout une dépendance à un syndrome de sevrage à la longue, une altération de la plasticité corticale le zolpidem qui est le stilnox risque de donner chez certains patients une dimension euphorique qui explique par moments le mésusage de cette substance et à la longue on peut avoir des troubles cognitifs

majeurs et pour les patients âgés il faut redouter des troubles posturaux avec l'existence parfois de chutes. Quant aux médicaments antistaminiques on peut avoir des états confusionnels et des somnolences et quelques effets anticholinergiques liés bien évidemment aux mécanismes d'action de cette molécule et on peut avoir une sécheresse de la bouche, une constipation, des troubles de l'accommodation, des troubles du rythme. Je disais au début de ce cours que les hypnotiques sont largement prescrits par les médecins généralistes et que cette prescription répond et doit répondre à certaines modalités qui bien évidemment protégeront le patient d'un certain nombre d'effets indésirables d'un certain nombre d'incompréhensions par rapport à leur usage et c'est ainsi que une des approches les plus importantes dans les troubles du sommeil étant une approche non pharmacologique et qui, comme vous l'avez bien constaté tous les cours concernant les psychotropes il y a ce qu'on appelle une éducation du patient en essayant de voir un peu les règles hygiéno-diététiques, examiner les rythmes veille-sommeil en fonction de l'âge et faire attention à tout ce qui est en rapport à tout ce qui est attrait aux facteurs de risque environnementaux. Le statut somatique du patient est très important ça ne serait-ce que pour éviter de prescrire un médicament alors qu'il y ait des contre-indications et caractériser la nature de l'insomnie entre l'aigu et le chronique, entre l'insomnie d'endormissement et les réveils nocturnes, entre la qualité du sommeil surtout quant à l'approche pharmacologique. Certaines caractéristiques du patient appellent à mieux connaître les règles de prescription des hypnotiques. Si on prend l'exemple d'un enfant les hypnotiques sont généralement à proscrire il va falloir prêter attention aux mesures hygiéno-diététiques et si c'est nécessaire une thérapie cognitive ou comportementale serait bien évidemment indiquée chez l'enfant et très efficace chez l'enfant. Chez la femme enceinte les hypnotiques utilisés sont généralement le zolpidem et le zopiclone et si on a une prescription avant l'accouchement il va falloir prêter attention et examiner le nouveau-né afin de voir, afin de déceler s'il existe des effets sédatifs ou anticholinergiques chez le nouveau-né. La femme allaitante le centre de référence des agents tératogènes préconise les mêmes hypnotiques c'est-à-dire le zolpidem et le zopiclone. Pour le sujet âgé on a tendance plus à donner de la mélatonine surtout on préconise une TCC puisque les hypnotiques donnent généralement des troubles posturaux très contraignants chez le sujet âgé afin d'optimiser le traitement des hypnotiques d'abord il faut choisir la molécule si on a une insomnie d'endormissement on va choisir un hypnotique à demi-vie courte pour maintenir le sommeil on aura tendance à donner un hypnotique à demi-vie longue la prise se fait généralement au coucher pas une heure avant ou une demi-heure avant il faut insister, quand on donne un médicament il faut expliquer au patient qu'il doit le prendre au moment du coucher la posologie se veut être progressive et il ne faut jamais dépasser la dose maximale si on a un sujet âgé qui a une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique on préconisera un comprimé de préférence sécable pour ne donner que la moitié de la dose qui est préconisée chez l'adulte. La durée du traitement est généralement de 2 à 5 jours dans les cas d'insomnie occasionnelle on aura tendance à avoir dans nos cabinets des patients qui viennent pour des dimensions de stress pour des changements de repères et qui veulent avoir ponctuellement un traitement hypnotique il ne faut pas dépasser 2 à 5 jours et dans les cas particuliers on aura bien

évidemment une durée de 3 semaines maximum pour pouvoir avec les mesures non pharmacologiques amener une réduction des troubles de sommeil et si on a un échec thérapeutique il ne faut pas renouveler systématiquement l'ordonnance mais il faut réévaluer le patient et réexaminer bien évidemment le symptôme du sommeil un 3ème point qui est très important étant l'information du patient et ce qu'on peut appeler entre guillemets le contrat de traitement la prescription, il faut l'expliquer au patient elle est ponctuelle que l'arrêt doit se faire d'une manière progressive et il ne faut jamais dépasser 4 semaines pour les mésodies épiniques y compris à la période du sevrage j'insiste sur ce dernier point qui est les mésodies épiniques parce que autant qu'anxiolytiques et hypnotiques ils seront largement prescrits donc il ne faut pas le prescrire de façon systématique sans évaluation du patient il ne faut pas méconnaître à ce patient une dépression ou un autre trouble psychiatrique à l'origine du trouble du sommeil il va falloir traiter le trouble d'origine et bien évidemment par conséquent agir sur le sommeil négliger un symptôme évocateur de syndrome d'apnée de sommeil il faut demander au patient s'il a un ronflement sonore s'il a des somnolences diurnes s'il a des céphalées au réveil ça évoque l'existence d'un syndrome d'apnée de sommeil qui, comme je venais de le dire tout à l'heure contre-indique les hypnotiques il ne faut jamais associer plusieurs benzodiazépines renouveler une ordonnance sans évaluer le patient et arrêter brutalement un traitement benzodiazépinique ou un apparenté une des modalités les plus importantes en termes de prescription des hypnotiques étant la tolérance et l'efficacité cela ne peut se faire qu'à partir d'une évaluation très rigoureuse et une information du patient et on ne peut avoir une efficacité et une tolérance meilleure que lorsqu'on associe une thérapie cognitive comportementale une éducation du patient au traitement hypnotique l'essentiel des modalités de prescription des hypnotiques étant que tous ces médicaments ne sont pas équivalents il faut prendre garde aux contre-indications et caractériser la nature de l'insomnie et du patient qui orienteront le choix de la molécule à prescrire informer le patient d'une nécessité d'une prise ponctuelle l'informer et qu'il prête attention à la conduite du véhicule n'hésitez pas à le mentionner sur votre ordonnance à la manipulation de certaines machines et à l'association des médicaments avec l'alcool que le traitement est de maximum 4 semaines et que les effets secondaires sont généralement passagers et gérables vous demanderez l'avis d'un psychiatre à propos d'une prescription d'hypnotique devant un tableau sévère de troubles de sommeil quand le traitement est insuffisamment efficace et ou mal toléré quand il y a la survenue d'événements intercurrents ou lorsque vous vous sentez dépassé par la situation en conclusion différentes classes d'hypnotique sont commercialisées au Maroc ils suppriment les symptômes sur la courte période une approche non pharmacologique doit être systématiquement associée il importe d'expliquer aux patients les modalités de prise de son médicament être attentif aux risques de dépendance et dire à la fin que les hypnotiques suppriment le sommet paradoxal ce qui explique leurs effets secondaires je vous souhaite une bonne écoute de ce cours sonorisé je vous remercie